

## FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

## SUMD · SCALE TO ASSESS UNAWARENESS OF MENTAL DISORDER

*Escala de Evaluación del Insight de Amador y Strauss – Batería semiestructurada multidimensional para la evaluación de la anosognosia y conciencia de enfermedad en psicosis*

## 1. Identificación General del Instrumento

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre oficial              | Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD)                                                     |
| Nombre en español           | Escala de Evaluación del Insight / Falta de Conciencia del Trastorno Mental                               |
| Sigla oficial               | SUMD                                                                                                      |
| Autores originales          | Xavier F. Amador, David H. Strauss, S. A. Yale, M. M. Flaum, J. Endicott y J. M. Gorman (1993, 1994)      |
| Adaptación hispanohablante  | Versión española validada (Ruiz, Amador et al., 2003; Bobes et al., 2004)                                 |
| Año de publicación original | 1993 (estudio fundacional del DSM-IV Schizophrenia Trial; versión española en 2003)                       |
| Constructo primario         | Conciencia de enfermedad ( <b>insight</b> / anosognosia), atribución de síntomas y adherencia terapéutica |
| Formato de administración   | Heteroaplicada mediante entrevista clínica semiestructurada e informe colateral                           |
| Población diana             | Pacientes adultos y jóvenes con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno bipolar              |
| Tiempo de aplicación        | 15 a 25 minutos (versión abreviada de 6 a 9 ítems) o 45 min (versión completa de 20 síntomas)             |
| Régimen de acceso           | Uso clínico y de investigación abierto de libre disposición respetando citación de autoría                |

## 2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder** (SUMD) representó un hito histórico en la psiquiatría al reconceptualizar el **insight** no como un fenómeno unitario o dicotómico (“el paciente tiene o no tiene conciencia”), sino como un constructo multidimensional, dinámico e independiente entre síntomas. Desarrollada en el Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons y el New York State Psychiatric Institute por Xavier F. Amador, la SUMD distingue entre la conciencia del trastorno como entidad global y la conciencia o atribución de síntomas específicos.

El marco clínico de la SUMD analiza de manera independiente dos dimensiones temporales (**conciencia en el momento actual** vs. **conciencia histórica retrospectiva durante la peor crisis**) y desglosa el constructo en tres subdominios nucleares: 1) Conciencia global de padecer una afección psiquiátrica; 2) Conciencia de los beneficios del tratamiento psicofarmacológico; y 3) Conciencia de las consecuencias sociales del trastorno (pérdida de empleo, hospitalizaciones, problemas relacionales). La anosognosia en la SUMD se conceptualiza como un déficit neurocognitivo primario del lóbulo frontal (similar a la anosognosia neurológica de Babinski) y no como una simple defensa psicológica de negación.

## 3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

| Dominio Clínico SUMD                    | N.º Ítems               | Rango         | Contenido Clínico y Operacionalización                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conciencia Global del Trastorno      | Ítem 1                  | 1 – 5         | Reconocimiento de tener una enfermedad psiquiátrica o problema de salud mental (1 = Plena conciencia; 5 = Ausencia total).      |
| 2. Conciencia Efectos Medicación        | Ítem 2                  | 1 – 5         | Comprensión de que los psicofármacos reducen síntomas y previenen recaídas (clave para adherencia terapéutica).                 |
| 3. Conciencia Consecuencias Sociales    | Ítem 3                  | 1 – 5         | Reconocimiento del impacto del trastorno en la convivencia familiar, laboral, legal y reingresos.                               |
| 4. Conciencia de Síntomas Específicos   | Variable (4 a 17 ítems) | 1 – 5<br>c/u  | Evaluación individualizada de: alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, afecto plano, anhedonia y desaliño personal. |
| 5. Atribución Causal de Síntomas        | Variable                | 1 – 5<br>c/u  | Atribución del origen de los síntomas reconocidos a la enfermedad mental frente a causas externas o persecutorias.              |
| <b>Puntuación Ítems Generales (1-3)</b> | <b>3 ítems</b>          | <b>3 – 15</b> | <b>Media o suma de ítems generales (3-15). Mayor puntuación = MAYOR ANOSOGNOSIA (peor insight).</b>                             |

#### 4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

| Propiedad Métrica                | Coefficiente / Hallazgo              | Contexto Empírico y Validación Hispana                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiabilidad interjueces (CCI)     | CCI = 0.86 – 0.95 en ítems generales | Excelente concordancia interevaluador tras entrenamiento formal en la entrevista semiestructurada.       |
| Consistencia interna general     | Alpha de Cronbach = 0.81 – 0.85      | Buena consistencia para los tres ítems generales y la escala global en muestras españolas.               |
| Fiabilidad test-retest           | r = 0.76 – 0.84 (fase eutímica)      | Estabilidad adecuada en pacientes crónicos estabilizados; sensibilidad a fluctuaciones agudas.           |
| Validez predictiva de adherencia | Correlación r = -0.68 con abandonos  | El ítem 2 (conciencia de medicación) es el predictor individual más firme de cumplimiento farmacológico. |
| Validez de constructo divergente | r = 0.15 a 0.28 con PANSS Positiva   | Demuestra que el insight es un dominio semiológicamente independiente de la gravedad de los delirios.    |

#### 5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Escala de Calificación Ordinal de 5 Puntos:**
  - **1 = Conciencia Plena / Conocimiento Completo:** El paciente reconoce claramente el trastorno o síntoma y lo atribuye adecuadamente a una condición psiquiátrica.
  - **2 = Conciencia Temprana / Leve Anosognosia:** Reconoce la existencia del síntoma pero duda sobre su naturaleza patológica.
  - **3 = Conciencia Parcial / Ambivalencia:** Reconoce el problema en ocasiones, pero a menudo lo niega o cambia de versión.
  - **4 = Conciencia Mínima / Marcada Anosognosia:** Reconoce de forma vaga que algo no va bien pero niega categóricamente el trastorno o síntoma.
  - **5 = Ausencia Total de Conciencia / Anosognosia Severa:** Negación absoluta; convicción irreductible de que no padece ninguna enfermedad.
  - **0 = No aplicable / El síntoma nunca ha existido:** Código especial para síntomas que no aplican al paciente.
- **Direccionalidad psicométrica:** A MAYOR puntuación, PEOR insight (mayor anosognosia).
- **Cómputo resumen:** Se utiliza la **Media de los Ítems Generales (Ítems 1 a 3)** (rango 1.0 a 5.0) o su suma directa (3 a 15).

#### 6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

| Media Ítems 1-3             | Nivel de Conciencia                 | Significación Psicopatológica y Riesgo de Desvinculación                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 – 1.9<br>(Suma 3 – 5)   | Insight Bueno / Preservado          | Conciencia completa o sustancial. Buena alianza terapéutica y excelente adherencia a psicofármacos.                                               |
| 2.0 – 3.4<br>(Suma 6 – 10)  | Insight Parcial / Fluctuante        | Conciencia ambivalente. El paciente acepta el tratamiento por presión externa o beneficio pragmático. Riesgo de abandono moderado.                |
| 3.5 – 5.0<br>(Suma 11 – 15) | Anosognosia Grave / Nula Conciencia | <b>Déficit neurocognitivo severo de conciencia.</b> Alto riesgo de abandono farmacológico inmediato, reingresos involuntarios y conflicto social. |

**PREDICTOR CLAVE DE ABANDONO TERAPÉUTICO (AMADOR ET AL., 1994):** Una puntuación de **4 o 5 en el Ítem 2** (Conciencia de los efectos del tratamiento) constituye el factor de riesgo independiente más potente de suspensión unilateral de la medicación antipsicótica y rehospitalización en los siguientes 6 meses.

## 7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

### Paso 1: Aplicación en estabilización post-aguda:

- Administrar la SUMD al remitir la agitación del brote psicótico o maníaco para planificar la continuidad de cuidados ambulatoria.

### Paso 2: Evaluación de discrepancias (Conciencia General vs. Conciencia de Síntomas):

- **Ítem 1 Alto (Anosognosia Global) pero Conciencia de Síntoma Específico (ej. Ítem 2 en 1 o 2 para el insomnio):** Utilizar la mejoría del insomnio o la angustia como "palanca motivacional" para pactar la toma de fármacos sin confrontar el diagnóstico de psicosis.

### Paso 3: Vía de abordaje psicoterapéutico y farmacológico:

- **SUMD Media 1.0 – 1.9:** Psicoeducación estándar sobre pródromos de recaída y formulación compartida de la enfermedad.
- **SUMD Media 2.0 – 3.4:** Terapia motivacional (técnica LEAP de Amador: **Listen, Empathize, Agree, Partner**) y entrevista motivacional adaptada.
- **SUMD Media  $\geq 3.5$  con antecedentes de abandono:** Indicación prioritaria de antipsicóticos inyectables de liberación prolongada (LAI) y designación de soporte familiar tutelado.

## 8. Caso Clínico Ilustrativo

**Identificación:** Varón de 27 años, con diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide de 4 años de evolución, derivado al Centro de Salud Mental tras su tercer ingreso hospitalario involuntario por descompensación delirante tras abandonar el tratamiento oral.

### Resultados en la Escala SUMD (Entrevista Semiestructurada):

- **Ítem 1 (Conciencia de padecer un trastorno mental): Puntuación = 5** ("Yo no estoy enfermo ni tengo nada en la cabeza; los psiquiatras me encierran por motivos políticos").
- **Ítem 2 (Conciencia de los efectos del tratamiento): Puntuación = 4** ("Las pastillas son veneno para controlarme, aunque admito que con ellas dormía mejor").
- **Ítem 3 (Conciencia de consecuencias sociales): Puntuación = 4** ("Perdí el trabajo porque mis compañeros me boicoteaban, no por ninguna crisis").
- Síntomas específicos: Conciencia de alucinaciones = 5 (niega oír voces); Conciencia de insomnio previo = 2.
- Media Ítems Generales: 4.33 / 5.0 (Anosognosia Grave).

**Decisión Terapéutica y Evolución:** La SUMD evidenció que la confrontación diagnóstica directa era inútil y perjudicial. Siguiendo el método LEAP, el psiquiatra pactó con el paciente una alianza centrada exclusivamente en "mantener el descanso nocturno y evitar nuevos ingresos no deseados", proponiendo la transición a un antipsicótico inyectable mensual (Palmitato de Paliperidona). El paciente aceptó el tratamiento bajo este marco pragmático. A los 12 meses de seguimiento continuado, no se produjeron nuevas recaídas ni rehospitalizaciones.

## 9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

### ALERTAS CLÍNICAS CRÍTICAS:

- **La "Paradoja del Insight":** La ganancia rápida de conciencia de enfermedad (descenso abrupto de 5 a 1 en Ítem 1) sin suficiente soporte psicoterapéutico se asocia a un aumento crítico de depresión post-psicótica y tentativas de suicidio.
- **Falso insight de complacencia:** Distinguir entre repetición verbal aprendida ("tengo esquizofrenia") y convicción funcional interna.
- **Riesgo legal:** Anosognosia severa combinada con suspicacia predice absentismo en revisiones y descompensaciones graves.

### DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Anosognosia neurocognitiva vs. Negación neurótica:** La negación psicológica defiende de una verdad dolorosa; la anosognosia neurobiológica es una imposibilidad cognitiva de percibir el déficit.
- **Trastorno Delirante Crónico:** En la paranoia el insight general suele estar abolido para el núcleo delirante encapsulado, con funcionamiento social aparentemente conservado.
- **Disfunción ejecutiva lóbulo frontal:** La falta de insight correlaciona con pruebas de flexibilidad cognitiva alteradas (WCST).

## 10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Amador, X. F., Strauss, D. H., Yale, S. A., Flaum, M. M., Endicott, J., & Gorman, J. M. (1993). Assessment of insight in psychosis. *American Journal of Psychiatry*, 150(6), 873–879. <https://doi.org/10.1176/ajp.150.6.873>
2. Amador, X. F., Flaum, M., Andreasen, N. C., Strauss, D. H., Yale, S. A., Clark, S. C., & Gorman, J. M. (1994). Awareness of illness in schizophrenia and schizoaffective and mood disorders. *Archives of General Psychiatry*, 51(10), 826–836. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1994.03950100074007>
3. Ruiz, A., Pousa, E., Duñó, R., Crosas, J. M., Cuquerella, M. A., & Amador, X. F. (2003). Adaptación española de la escala de evaluación de la falta de conciencia de trastorno mental (SUMD). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 31(Supl 1), 60.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.